

Cáncer laríngeo: factores de riesgo y signos de alarma

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer laríngeo** es el tumor maligno más frecuente de la vía aérea superior y constituye una de las **neoplasias más prevenibles** debido a su fuerte asociación con el **tabaco y el alcohol**.

Corresponde al **1–2% de todos los cánceres** en Chile y al **25–30% de los tumores de cabeza y cuello**.

La laringe es una estructura vital para la **respiración, fonación y deglución**, por lo que su compromiso tumoral tiene **consecuencias funcionales significativas**. El **diagnóstico precoz** permite tratamientos conservadores y **preservación de la voz**.

Epidemiología

- **Edad promedio al diagnóstico:** 60 años.
- **Sexo:** predominio masculino (relación 6:1), aunque en aumento en mujeres.
- **Localización más frecuente:** **glotis (60–70%)**, seguida de **supraglotis (25–30%)** y **subglotis (5%)**.

Relevancia clínica

- **Síntoma cardinal:** **disfonía persistente >3 semanas**.
- Diagnóstico precoz = curación potencial con mínima secuela funcional.
- En APS y EUNACOM, el **mensaje clave** es **reconocer los signos de alarma** y derivar oportunamente a ORL.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía oncológica de la laringe

La laringe se divide anatómicamente en tres compartimientos:

Región	Límites anatómicos	Características clínicas
Supraglótica	Epiglotis, pliegues aritenopiglóticos, bandas ventriculares	Rápida diseminación linfática.
Glótica	Cuerdas vocales verdaderas	Diagnóstico precoz por disfonía temprana.
Subglótica	Desde 1 cm bajo la glotis hasta el borde inferior del cricoides	Diagnóstico tardío; disnea como síntoma inicial.

2.2 Histología

- **>90% son carcinomas epidermoides (escamosos).**
 - Otros menos frecuentes:
 - Adenocarcinoma (glándulas submucosas).
 - Carcinoma verrucoso.
 - Carcinosarcoma.
 - Linfoma o metástasis secundarias.
-

2.3 Patogénesis

La carcinogénesis laríngea es un proceso **multietápico**:

1. Exposición crónica a **carcinógenos inhalados** (tabaco, alcohol, irritantes).
2. **Metaplasia escamosa → displasia → carcinoma in situ → invasor.**
3. En etapas iniciales, limitada a la mucosa; luego invade cartílago, tejidos blandos y estructuras adyacentes.

El **papilomavirus humano (VPH 16 y 18)** también juega un rol en una fracción de tumores laríngeos, especialmente en pacientes más jóvenes y no fumadores.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas según localización

Localización	Síntoma inicial más frecuente	Otros síntomas
Glótica	Disfonía progresiva	Odinofonía, tos seca, sensación de cuerpo extraño.
Supraglótica	Odinofagia, disfagia, masa cervical	Disfonía tardía, otalgia referida.
Subglótica	Disnea progresiva	Tos, estridor, hemoptisis leve.

☐ La disfonía persistente en un fumador siempre debe considerarse cáncer laríngeo hasta demostrar lo contrario.

3.2 Síntomas generales

- **Disfonía** (>3 semanas, progresiva).
 - **Disfagia u odinofagia.**
 - **Tos irritativa.**
 - **Hemoptisis leve o esputo sanguinolento.**
 - **Dolor otálgico referido (signo de Jackson).**
 - **Disnea progresiva o estridor.**
 - **Masa cervical palpable (adenopatía metastásica).**
-

3.3 Signos de alarma (para derivación urgente a ORL)

1. Disfonía persistente >3 semanas, especialmente en fumadores.
 2. Dolor al tragar o irradiado al oído.
 3. Dificultad respiratoria o estridor.
 4. Tos con sangre.
 5. Masa cervical persistente.
 6. Pérdida de peso o anorexia.
 7. Antecedente de exposición a tabaco, alcohol o irritantes crónicos.
-

3.4 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clínicas
Laringitis crónica / reflujo laringofaríngeo	Disfonía leve, fluctuante, mejora con tratamiento.
Nódulos o pólipos vocales	Disfonía sin dolor ni hemoptisis.
Papilomatosis laríngea	Lesiones múltiples, en jóvenes, curso benigno.
Parálisis de cuerda vocal	Voz soplada, aspiración, sin masa ni dolor.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial en APS

- Anamnesis dirigida: duración de disfonía, hábito tabáquico, exposición laboral.

- Examen físico de cabeza y cuello: búsqueda de masa cervical, lesiones orales o faríngeas.
 - **Derivación inmediata a ORL** ante disfonía persistente o signos de alarma.
-

4.2 Evaluación especializada

Examen	Utilidad
Laringoscopia flexible o indirecta	Visualiza lesión (ulcerada, exofítica o infiltrante).
Biopsia laríngea bajo anestesia general	Confirma el diagnóstico histológico.
TAC o RM de cuello y tórax	Determina extensión local y metastásica.
PET-CT (si disponible)	Evalúa diseminación ganglionar o a distancia.
Evaluación funcional (fonoaudiología, nutrición)	Pre y post tratamiento.

4.3 Estadificación TNM (según AJCC 8.^a edición)

T (tumor primario):

- T1: limitado a una región (ej. cuerda vocal, con movilidad conservada).
- T2: extensión a regiones adyacentes o movilidad disminuida.
- T3: fijación de cuerda vocal o invasión de espacio paraglótico.
- T4: invasión de cartílago o estructuras extralaringeas.

N (ganglios linfáticos):

- N0: sin metástasis ganglionares.
- N1–N3: compromiso ganglionar creciente.

M:

- M0: sin metástasis a distancia.
- M1: metástasis a distancia presentes.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Principios generales

El objetivo terapéutico es **erradicar el tumor preservando la función laríngea** (voz y respiración).

El manejo depende de la **localización, extensión y estado funcional del paciente**.

5.2 Tratamiento por estadio

Estadio	Tratamiento principal	Observaciones
I–II (localizados)	Radioterapia exclusiva o microcirugía endoscópica con láser CO ₂	Alta tasa de curación (>85%), preserva voz.
III (localmente avanzado)	Cirugía + radioterapia adyuvante o quimiorradioterapia concurrente	Laringectomía parcial o total según extensión.
IV (avanzado o metastásico)	Laringectomía total + radioterapia y/o quimioterapia sistémica	Posible traqueostomía permanente.

5.3 Manejo complementario

- **Rehabilitación vocal:** fonoaudiología postoperatoria o con prótesis fonatoria.
 - **Rehabilitación respiratoria:** en laringectomizados totales.
 - **Nutrición:** gastrostomía temporal en casos de disfagia.
 - **Psicología oncológica:** apoyo ante secuelas funcionales y emocionales.
-

5.4 Tratamiento de soporte y paliativo

- En enfermedad avanzada no resecable:
 - Radioterapia paliativa (control del dolor y sangrado).
 - Quimioterapia paliativa (cisplatino + 5-FU, o inmunoterapia con pembrolizumab).
 - Cuidados paliativos integrales.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones del tratamiento

- **Disfonía o afonía permanente.**
 - **Estenosis laringotraqueal.**
 - **Disfagia o aspiración crónica.**
 - **Hipotiroidismo post radioterapia.**
 - **Fístulas faríngeas postquirúrgicas.**
 - **Complicaciones psicológicas:** depresión, aislamiento social.
-

6.2 Pronóstico

- **Depende del estadio al diagnóstico:**
 - Etapas iniciales: supervivencia a 5 años **>90%**.
 - Etapas avanzadas: supervivencia **<50%**.
 - Mejor pronóstico en tumores **glóticos**, por detección temprana (disfonía).
 - Factores pronósticos negativos:
 - Tabaco continuado.
 - Diagnóstico tardío.
 - Invasión cartilaginosa o metástasis ganglionares.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Disfonía >3 semanas en fumador → cáncer laríngeo hasta demostrar lo contrario.**
 2. La **localización glótica** es la más frecuente y con mejor pronóstico.
 3. El **diagnóstico es histológico**, confirmado por **biopsia laríngea**.
 4. **TAC de cuello y tórax** se utiliza para evaluar extensión local y regional.
 5. El **tratamiento precoz** permite preservar la voz (radioterapia o microcirugía).
 6. En etapas avanzadas, puede requerir **laringectomía total y traqueostomía permanente**.
 7. Todo paciente tratado requiere **seguimiento oncológico y rehabilitación fonoaudiológica**.
-

Errores comunes

- Tratar disfonía crónica con antibióticos o corticoides sin estudio.

- No derivar a ORL tras 3 semanas de disfonía.
 - Omitir examen de cuello (masa ganglionar palpable).
 - No interrogar hábito tabáquico ni exposición a irritantes.
 - Ignorar el componente psicológico del paciente laringectomizado.
 - No considerar rehabilitación vocal postoperatoria.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **cáncer laríngeo** es el tumor maligno más frecuente de la vía aérea superior.
2. **Principal síntoma:** disfonía progresiva, especialmente en fumadores.
3. **Factores de riesgo:** tabaco, alcohol, VPH, exposición a irritantes.
4. **Diagnóstico:** laringoscopia + biopsia + TAC de extensión.
5. **Tratamiento:** radioterapia o cirugía según estadio; rehabilitación vocal posterior.
6. **Pronóstico excelente** en tumores glóticos diagnosticados precozmente.
7. **Toda disfonía >3 semanas debe derivarse a ORL.**